جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : روحيه عبدالعزيز سلام قاسم
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** روض الفرج **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 24801082300329 **رقم التليفون :** 01016591547 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 08-01-1948 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: روحيه عبدالعزيز سلام قاسم
National ID: 24801082300329

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جوستافروسي انترناشونال مصر

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 17/9/2025 G

Name	[illegible]	MRN	177161c.co
Age	80	ID	01017591547
Menopausal status		Phone	01030048213
NRS SCORE		Marital status	married
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	hypertsive	REASON OF MDT	post-op

cen. inc+..2cq

Clinical Data

BX: IDC GII + wide DCIS

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
818	818	0	5%.

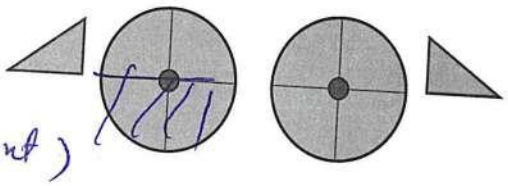
inv

Sonomammography:

S/P :- Rt SM+SINUS (subfront)

Mets Workup: marked autolytic changes
Invasive Duct carcinoma, G2 with DCIS
- free LN (0/16)
- free nipple, free margin

R L



inv. TNM $_{2}^{}$ $_{0}^{}$ $_{0}^{}$

Recommendations:
- Postive microcalcification
- Stage: pT1c, pN1

16/9/2025

MDT OUTCOME & PLAN

Dual A
80 y.o / T_2N_0 } for Post op AI + Zoledta 16
YP $T_{1c}N_1$

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / روحيه عبدالعزيز سلام قاسم	Request No.	: 13007413
Patient No.	: 24801082300329	Request Date	: 24/05/2025
Path No.	: 1893/25	Verification Date	: 04/06/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 80 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 9 O'clock mass, BIRADS IVb.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 22/05/2025.

Gross Examination:
- Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm long, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Widely detected.
* Perineural invasion: Not detected.
* Angioinvasion: Not detected.

* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 5% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II, With wide DCIS.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) - الدور الأول - عقار رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Cornich - Masr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / روحيه عبدالعزيز سلام قاسم	Request No.	: 13007413
Patient No.	: 24801082300329	Request Date	: 24/05/2025
Path No.	: 1893/25	Verification Date	: 04/06/2025
Sex	: Female	Financial Category	: اوراما دار السلام - مبادره
Age	: 80 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative, (score 0).
- Ki67: Positive in 5 % of tumor cells.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and
within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on
circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ebrahem Ghoneim.
Dr. Heba Hassan.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الاول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Cornicha - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Rawheya Abdel Aziz Sallam Kasem	Date : 20/05/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 77 Year(s)
Medical ID: 24801082300329	Pat. ID: 99716

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

Right breast palpable mass and bleeding per-nipple

Report:

- ACR a: almost entirely fatty parenchyma
- Right Breast:
  - Ill-defined equally dense global retro-areola asymmetry extending into the outer quadrants. Ultrasound shows corresponding ill-defined isoechoic irregular mass at 9O'clock measuring 27x20mm extending into central ducts reaching the nipple.
  - No pathologically enlarged axillary lymph nodes
  - No supra or infraclavicular lymph node.
- Left Breast:
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - Retro-areola simple cyst
  - Complementary ultrasound no solid mass lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Right breast suspicious mass for histopathological assessment (BIRADS 4b)
- Left retro-areola simple cyst (BIRADS 2)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
20/05/2025 2:25 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name: Rawheya Abdel Aziz Sallam Kasem	Date : 17/07/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 77 Year(s)
Medical ID: 1668/2025	Pat. ID: 99716

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Right breast lobulated mass lesion is seen for sonomammographic assessment.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definte enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name: Rawheya Abdel Aziz Sallam Kasem	Date : 17/07/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 77 Year(s)
Medical ID: 1668/2025	Pat. ID: 99716

- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:** no definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.

Opinion:

- **Right breast lobulated mass lesion is seen for sonomammographic assessment.**
- **No evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.**

Signature Dr.Mohamed Hassan
23/07/2025 02:05 م

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]